

Trzy modele *interwencji rodzinnej*

NICE rekomenduje 10+ sesji interwencji rodzinnej dla każdej osoby z psychozą mieszkającej z rodziną. Trzy modele: behawioralny, multifamily, Open Dialogue.

CZAS: 15 min · planowanie Dla rodziny i klinicystów

ŹRÓDŁO: Falloon i in. (1984); McFarlane (1995); Seikkula i in. (2003); Pharoah Cochrane (2010)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **trzy główne modele** interwencji rodzinnej (sekcja 1), zrozum **pięć wspólnych komponentów** łączących wszystkie podejścia (sekcja 2) i sprawdź, **który model** może najlepiej pasować do Twojej sytuacji (sekcja 3).

DLACZEGO TO DZIAŁA

NICE (2014, CG178): interwencja rodzinna jest **standardem leczenia** psychozy, gdy pacjent mieszka z rodziną lub bliskimi. Pharoah i in. (2010, Cochrane): interwencje rodzinne **redukuja nawroty o 20-50%**, hospitalizacje i obciążenie opiekunów. Mimo tej silnej rekomendacji — w praktyce *niewiele* rodzin otrzymuje pełną interwencję (10-20 sesji). Jednorazowe spotkanie psychoedukacyjne to **nie** interwencja rodzinna. Trzy modele dają trzy ścieżki, ale wspólny mianownik: *psychoedukacja, komunikacja, rozwiązywanie problemów, redukcja EE, plan kryzysowy*.

01 📖 Trzy modele interwencji rodzinnej

FALLOON — BEHAWIORALNY

pojedyncza rodzina

10-20 sesji w domu rodziny. Strukturyzowane bloki: psychoedukacja → trening komunikacji → rozwiązywanie problemów. **Najszerzej replikowany** w RCT. Falloon (1984): redukcja nawrotów z 50% do 11% w 2-letnim follow-up.

MCFARLANE — MULTIFAMILY

grupa 5-8 rodzin

Grupa kilku rodzin spotyka się *razem*. Każda dzieli się doświadczeniami, uczą się od siebie nawzajem. **Tańszy** niż model Falloona, równie skuteczny. McFarlane (2002): peer learning + redukcja izolacji rodzin.

SEIKKULA — OTWARTY DIALOG

sieć społeczna pacjenta

Finlandzki model. *Szybka odpowiedź* (w ciągu 24 h od kryzysu), spotkania z *całą siecią* (rodzina, przyjaciele, sąsiedzi). Mniej leków, więcej rozmowy. Seikkula (2003): 80% remisji bez antypsychotyku w FEP.

02 🗨️ Pięć wspólnych komponentów

1 · PSYCHOEDUKACJA

Czym jest psychoza, model podatność-stres, objawy pozytywne i negatywne, rola leków, czego oczekiwać. Wiedza redukuje strach i bezradność.

2 · TRENING KOMUNIKACJI

Aktywne słuchanie, prośby pozytywne (zamiast krytyki), wyrażanie uczuć. Stosunek 5:1 (5 docenień / 1 wymaganie). Bezpośrednio redukuje EE.

3 · WSPÓLNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Konkretne trudności (kłótnia, decyzje finansowe, plan dnia) rozkładane wspólnie na małe kroki. Rodzina jako zespół, nie strony konfliktu.

4 · PLAN KRYZYSOWY

Wczesne sygnały nawrotu, telefony kryzysowe, kto co robi przy zaostrzeniu. Plan na piśmie, dostępny dla wszystkich domowników.

5 · SELF-CARE OPIEKUNÓW

Opiekun wypalony = gorsze wyniki leczenia. Eksplicytna rozmowa o granicach, własnym życiu opiekuna,

03

Który model najlepiej pasuje

Wybór zależy od sytuacji rodziny, dostępności w regionie i preferencji. Najważniejsze, by **w ogóle** była interwencja — niż brak. Jeśli żaden z modeli nie jest dostępny — psychoedukacja rodziny w 2–3 sesjach jest lepsza niż nic.

JAKI MODEL JEST DOSTĘPNY W NASZEJ OKOLICY

— spytaj psychiatrę, CZP, lokalne fundacje

CZEGO NAJBARDZIEJ POTRZEBUJEMY

— komunikacja, plan kryzysowy, psychoedukacja, kontakt z innymi rodzinami

04

Gdzie szukać w Polsce

CENTRA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

CZP w Twoim rejonie. Wiele oferuje psychoedukację rodzin i grupy wsparcia. Bezpłatne w ramach NFZ.

STOWARZYSZENIA RODZIN

Polska Federacja „Stowarzyszenia Rodzin Osób Chorych Psychiczenie”. Lokalne stowarzyszenia w większych miastach. Grupy wsparcia, mityngi.

OTWARTY DIALOG

Polska Sieć Otwartego Dialogu w Krakowie, Toruniu, Warszawie. Szkolenia dla rodzin i klinicystów. Eksperymentalne wdrożenia w niektórych CZP.

Klucz: rodzina **nie jest problemem** — to *najważniejszy zasób* w leczeniu psychozy, gdy jest **wsparta** wiedzą i umiejętnościami. Pharoah Cochrane (2010): $NNT = 7$ — wystarczy *siedem* rodzin objętych interwencją, by zapobiec jednemu nawrotowi. To efekt porównywalny z większością leków psychiatrycznych. NICE rekomenduje *od pierwszego epizodu*, nie po latach choroby. Jeśli psychiatra nie proponuje — **zapytaj o to aktywnie**. Otwarty Dialog (Seikkula, Finlandia, Laponia Zachodnia): 20-letnie wyniki — 80% pacjentów FEP funkcjonuje normalnie, większość bez ciągłej farmakoterapii. Model ten zmienia paradygmat leczenia psychozy.